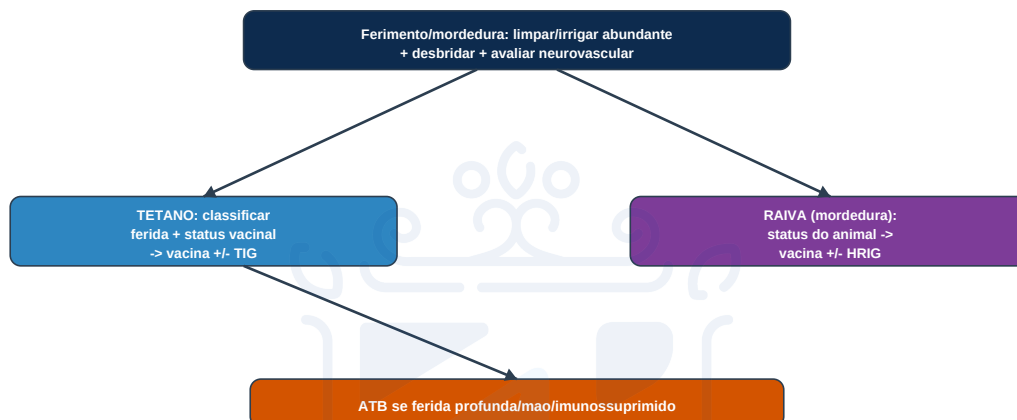


MORDEDURAS E PERFURAÇÕES — TÉTANO + RAIVA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

FERIMENTO -> LAVAR -> PROFILAXIA (TÉTANO ± RAIVA)



AValiação e Cuidados Locais

LIMPEZA É A BASE

- Anamnese: tempo, mecanismo, tipo de objeto (enferrujado/sujo), animal e status vacinal antirrábico, comorbidades (DM/imunossupressão), vacinação antitetânica do paciente
- Exame: extensão/profundidade, corpo estranho, lesão neurovascular/tendínea, localização (mão/pé/articulação)
- Controle de sangramento + IRRIGAÇÃO ABUNDANTE (SF/água e sabão, idealmente ≥ 100 mL/cm de ferida)
- Desbridar tecido desvitalizado e remover corpos estranhos; analgesia local
- RX se corpo estranho profundo, suspeita de fratura ou objeto retido (ex.: prego)

PROFILAXIA ANTITETÂNICA

Situação vacinal	Ferida limpa	Ferida suja/alto risco
< 3 doses ou incerta	Vacina (completar esquema)	Vacina + TIG 250 UI IM
≥ 3 doses, última < 5 anos	Nada	Nada
≥ 3 doses, última 5-10 anos	Nada	Vacina (reforço)
≥ 3 doses, última > 10 anos	Vacina (reforço)	Vacina (reforço)

PROFILAXIA ANTIRRÁBICA (MORDEDURA)

RAIVA É FATAL — DECISÃO PELO ANIMAL

- Cão/gato SADIO e observável por 10 dias: observar o animal e reavaliar (postergar/suspender se permanecer sadio)
- Animal desconhecido, não observável, suspeito/raivoso, ou agressão grave: iniciar profilaxia
- Não vacinado previamente: vacina IM nos dias 0, 3, 7 e 14 (esquema do MS); + IMUNOGLOBULINA (HRIG) infiltrada ao redor da ferida no dia 0 nas exposições graves
- Já vacinado previamente: reforço apenas nos dias 0 e 3, SEM imunoglobulina
- Lavar exaustivamente a ferida com água e sabão é também medida antirrábica essencial

ANTIBIÓTICO E FECHAMENTO

Rx QUANDO TRATAR E SUTURAR

ATB profilático/terapêutico: Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12h por 3-5d (profilaxia) ou 5-7d (infestado)

Alérgico: Doxíciclina (evitar < 8 anos/gestante) ou Clindamicina + SMX-TMP

Indicações de ATB: feridas profundas/punção/esmagamento, mãos/pés/perto de articulações, imunossupressão/prótese, fechamento primário planejado

FECHAMENTO: a maioria das mordeduras cicatriza por 2ª intenção; primário só em feridas faciais limpas, bem irrigadas e com ATB; EVITAR sutura em ferida > 12h em extremidades

Antibiótico NÃO previne tétano (a prevenção é vacina/TIG + limpeza)

Elevar o membro 24-48h, curativo diário

INTERNAÇÃO E MODELO DE REGULAÇÃO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Internar se: infecção grave (febre, edema/calor intenso), envolvimento de artéria/nervo/tendão, comprometimento funcional, miosite/celulite progressiva, falha terapêutica
- Paciente ____ anos; ferimento ____ (mordedura/prego), local ____, há ____; objeto sujo/enferrujado ____.
- Vacinação antitetânica ____ (doses/última); ferida limpa/suja ____; status do animal ____ (vacinado/observável?).
- Conduta: irrigação/desbridamento, antitetânica (vacina ± TIG), antirrábica (vacina ± HRIG), ATB ____; solicito cirurgia/ortopedia se lesão profunda/articular.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com ferimento sujo/profundo (alto risco para tétano) e vacinação incerta (< 3 doses). Qual a conduta?

- A) Apenas limpeza
- B) Vacina antitetânica + imunoglobulina antitetânica (TIG 250 UI IM)
- C) Somente antibiótico
- D) Nenhuma profilaxia
- E) Apenas reforço sem TIG

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Mordedura de cão SADIO, passível de observação por 10 dias. Qual a conduta antirrábica?

- A) Iniciar imediatamente vacina + imunoglobulina em todos
- B) Lavar a ferida e observar o animal por 10 dias, reavaliando a necessidade de profilaxia
- C) Eutanásia imediata do animal
- D) Apenas antibiótico
- E) Nenhuma medida

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o antibiótico de primeira linha para profilaxia/tratamento de mordedura de cão?

- A) Azitromicina
- B) Amoxicilina-clavulanato
- C) Cefalexina isolada
- D) Penicilina cristalina
- E) Metronidazol isolado

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o fechamento de feridas por mordedura, é correto:

- A) Suturar sempre, em qualquer tempo e local
- B) A maioria cicatriza por 2ª intenção; fechamento primário só em face limpa/bem irrigada; evitar sutura em ferida > 12h em extremidades
- C) Nunca lavar antes de suturar
- D) Suturar todas as feridas de mão
- E) Fechamento primário é obrigatório

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual medida é mais importante para reduzir o risco de infecção (e de raiva) em mordeduras e ferimentos?

- A) Antibiótico de amplo espectro isolado
- B) Irrigação/lavagem abundante com água e sabão e desbridamento
- C) Corticoide tópico
- D) Sutura imediata
- E) Imobilização gessada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Ferida suja/alto risco com vacinação incerta ou < 3 doses indica vacina antitetânica + imunoglobulina antitetânica (TIG 250 UI IM, em local distinto da vacina).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Cão sadio e observável por 10 dias permite lavar a ferida e observar o animal, reavaliando a profilaxia; inicia-se profilaxia se o animal for desconhecido/não observável, suspeito, ou em agressão grave.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A amoxicilina-clavulanato é a primeira linha (cobre *Pasteurella*, anaeróbios e flora oral do animal); alérgicos: doxiciclina ou clindamicina + SMX-TMP.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A maioria das mordeduras cicatriza por segunda intenção; o fechamento primário fica restrito a feridas faciais limpas e bem irrigadas (com ATB), evitando-se sutura em feridas > 12h em extremidades.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A irrigação/lavagem abundante com água e sabão, com desbridamento, é a medida mais importante para reduzir infecção e também integra a profilaxia antirrábica; o antibiótico não previne tétano.

SM24
Suporte ao Plantão Médico